ONEMA-POP-059 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

Suspeita de Neurotoxicidade por Opioides e Mioclonias em Cuidados Paliativos

1. Identificação institucional

2. Objetivo e abrangência

Padronizar avaliação, decisão, execução e comunicação no contexto de suspeita de neurotoxicidade por opioides e mioclonias em cuidados paliativos, em atendimento domiciliar presencial ou remoto conforme aplicabilidade. Não substitui prescrição, avaliação médica nem instruções do fabricante.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado e capacitado; executar intervenções apenas no âmbito legal, da prescrição e do protocolo institucional.

Não realizar manipulação invasiva quando não houver indicação, treinamento, material adequado ou estabilidade clínica.

4. Materiais e fornecimento

Lista de opioides e adjuvantes, escala de sedação/dor, avaliação respiratória. Equipamentos profissionais/EPIs: enfermeiro ONEMA; consumíveis específicos: paciente/responsável, salvo ajuste contratual. Em visita presencial, equipamentos de avaliação clínica conforme indicação.

5. Avaliação e preparo

Investigar mioclonias, alucinações, delirium, hiperalgesia, função renal, dose e mudanças recentes. Confirmar identificação, consentimento, alergias, medicamentos, ambiente, suporte disponível e condições para encaminhamento.

6. Execução técnica numerada

01. Identificar opioide, dose, intervalo, via, última administração e mudanças recentes.

02. Avaliar consciência, padrão respiratório, mioclonias, dor, alucinações e hidratação.

03. Considerar causas alternativas como distúrbios metabólicos e delirium; não atribuir automaticamente ao opioide.

04. Na suspeita de toxicidade, comunicar prescritor/equipe paliativa imediatamente para revisão de dose ou rotação.

05. Não orientar suspensão abrupta, rotação ou antídoto por decisão remota sem plano médico específico.

06. Se depressão respiratória, inconsciência ou cianose, acionar SAMU 192.

07. Reavaliar após medidas prescritas, documentando alívio e efeitos adversos.

08. Registrar medicamento, sinais, horários, comunicação e plano.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Depressão respiratória, sedação profunda, instabilidade: emergência. Na emergência, acionar SAMU 192 e registrar o horário. Não insistir em procedimento inseguro.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar família a observar sonolência, respiração e movimentos involuntários.

9. Carteira Digital ONEMA

Registrar data/hora, modalidade, identificação e consentimento, achados positivos e negativos, sinais vitais se pertinentes,

intervenção passo a passo, materiais/dispositivo quando aplicável, intercorrências, comunicação, encaminhamento,

orientações, plano de seguimento e identificação profissional.

10. Referências técnicas rastreáveis

NICE NG31 symptom management; Scottish Palliative Care Guidelines opioid toxicity (verificação local pendente) | Conferir

aplicação integral ao cenário brasileiro e IFU específico antes de liberação assistencial.

aplicativo.